Insuficiencia cardíaca

SEMIOLOGIA · Clase 01 · de la falla del ventrículo a cada síntoma

1 · QUÉ ES Y SUS TRES FORMAS

Insuficiencia cardíaca
congestión venosa pulmonar y/o sistémica con débito cardíaco disminuido

según qué ventrículo falle

Tres formas que se superponen
izquierda, derecha y congestiva o global

se distingue por ser

Izquierda subjetiva, derecha objetiva
la izquierda se refiere y se oye (disnea, crepitantes); la derecha se ve (yugular, hígado, edema)

2 · FALLA IZQUIERDA: POR QUÉ SE MOJA EL PULMÓN

Causas de la falla izquierda
HTA (la más frecuente), infarto, miocardiopatías y valvulopatía mitral o aórtica

si falla el izquierdo, se debe a

impiden un buen

Vaciamiento insuficiente
sube el volumen residual y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo

por eso la izquierda es subjetiva:

sale menos sangre por la

la presión retrocede por la

F1

Vía retrógrada: hipertensión venocapilar
la presión pasa a la aurícula izquierda y a los capilares del pulmón: congestión pulmonar

Vía anterógrada
llega poco flujo a músculos y cerebro: fatiga y astenia

cronificada, sobrecarga al

eleva la presión capilar a

F14

Presión capilar pulmonar
normal 10-12 mmHg; en la falla izquierda llega a 25-35 mmHg

si es extremo marca la gravedad:

al superar a la oncótica produce

Extravasación
la presión capilar supera a la oncótica y el agua sale al intersticio y luego al alvéolo

3 · FALLA IZQUIERDA: SÍNTOMAS Y SIGNOS

Punta desviada afuera y abajo
por hipertrofia del VI; además pulso pequeño y PA convergente

al palpar el precordio, la

F4

Crepitantes en las bases
el líquido alveolar crepita al abrirse en la inspiración: signo de congestión pasiva

Disnea de esfuerzo, ortopnea y DPN
acostado vuelve más sangre al pulmón; la disnea paroxística nocturna aparece tras horas de sueño

si falla el derecho, se debe a

si es nocturna y con sibilancias es

al auscultar, el líquido da

el ventrículo lleno y dilatado da el

Asma cardíaca
disnea nocturna con sibilancias, taquicardia, galope y crepitantes basales; mejora al sentarse

encharca el pulmón y da

si se agrava llega al

F2

Edema agudo de pulmón
la presión capilar supera bruscamente a la oncótica y el alvéolo se inunda: hipertensión venocapilar

si ocurre de golpe llega al

al inundarse el alvéolo da

F3

Esputo seroso, espumoso y rosado
plasma trasudado con aire y algo de sangre: agua de lavar carne

se confirma con la

F5

Ritmo de galope
R3 o R4 patológico (como un caballo); campana suave en la punta y decúbito lateral izquierdo

es la forma más grave:

es un signo de alarma:

La **congestión pulmonar o el bajo débito** marcan la gravedad de la falla izquierda

4 · FALLA DERECHA: CAUSAS Y CONGESTIÓN DE LAS CAVAS

Causas de la falla derecha
falla izquierda previa (hipertensión pulmonar), cor pulmonale (EPOC), valvulopatía tricuspídea y pericarditis constrictiva

sobrecargan y producen la

Altura
la hipoxia crónica causa poliglobulia (enfermedad de Monge) y sobrecarga el corazón derecho sin valvulopatía

por poliglobulia sobrecarga el

Falla del ventrículo derecho
sube la presión en la aurícula derecha y se transmite a las venas cavas

la presión retrocede a la

Congestión sistémica
la sangre se estanca en la cava superior e inferior y se hincha todo lo que drena allí

en las serosas produce el

al palpar el precordio, la

5 · FALLA DERECHA: LO QUE SE VE Y SE PALPA

en los miembros produce el

Punta desviada hacia el esternón
por hipertrofia del ventrículo derecho

en el peritoneo produce

Ascitis
si impide palpar el borde, el hígado se palotea: signo del témpano

F8

Edema de miembros inferiores
bilateral, simétrico, ascendente y con Godet: de la falla derecha, no de la izquierda pura

F9

Derrame pleural
trasudado (presión sin inflamación), más frecuente a la derecha y en las bases

se suma a la

todo esto se ve y lleva a la

apoya el diagnóstico de la

La **congestión visible** conduce al diagnóstico de falla derecha

en el cuello produce la

F7

Yugular ingurgitada
se ve con el tronco a 30-45°; también en falla congestiva, taponamiento cardíaco y síndrome mediastínico

en el hígado produce la

F6

Hepatomegalia dolorosa
la cápsula de Glisson se distiende; es de la falla derecha, no de la izquierda

al comprimirlo se hace el

no toda hepatomegalia es cardíaca:

se pone a prueba con el

Reflujo hepatoyugular
comprimir el hígado 30-60 segundos

F12

Otras causas de hepatomegalia (🧤)
tumores, colestasis extrahepática, cirrosis, esteatosis, quiste hidatídico, hepatitis viral y linfoma; la cardíaca crónica con ictericia es cirrosis cardíaca

si la yugular sube y se mantiene,

Si la yugular **se hincha más y se mantiene**, la congestión derecha queda confirmada

6 · EL EDEMA: CUÁNDO SE HINCHA Y POR QUÉ SE PERPETÚA

Godet y cruces
presionar la tibia, nunca la pantorrilla: de 1 a 4 cruces (4 = anasarca)

el grado más alto es la

Anasarca: edema generalizado, con ascitis y derrames

SRAA: hiperaldosteronismo secundario
el bajo débito retiene sodio y agua y perpetúa el edema

se mide con el

retiene sodio y agua hasta la

tiene un horario típico: el bajo débito activa el

F10

Edema cardíaco vespertino
en los tobillos al final del día: de pie el agua se acumula en las piernas

a diferencia del

F10

Edema renal matutino
en los párpados al despertar (nefrótico: facial, luego generalizado)

de noche se reabsorbe y da

Nicturia
acostado, el edema vuelve a la sangre y se orina: señal precoz

confirma el patrón vespertino:

el horario orienta al órgano:

el horario orienta al órgano:

Por la **hora**: matutino, riñón; vespertino, corazón

7 · CÓMO SE CONFIRMA: RADIOGRAFÍA Y CRITERIOS

se confirma con la

Radiografía de tórax
muestra el tamaño del corazón y el pulmón; el ECG y el ecocardiograma la completan

cuenta como criterio

en la placa se calcula el

se completa con ECG y

F13

Índice cardiotorácico
(A + B) / C en la radiografía de frente; normal hasta 0,50

F11

Criterios mayores (🧤)
disnea paroxística nocturna, yugular ingurgitada, crepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón y tercer ruido

pesan más que los

Otros exámenes
hemograma, función renal, electrolitos y gases arteriales

si supera 0,50 hay

aporta datos para el

Sobre 0,50: **cardiomegalia**

F11

Criterios menores (🧤)
edema, disnea de esfuerzo, hepatomegalia y derrame pleural: poco específicos

es criterio mayor y apoya el

en conjunto sostienen el

El conjunto de síntomas, signos y radiografía **confirma la falla cardíaca** y señala su lado

cuenta como criterio

si fallan ambos se llama

sumada a la izquierda forma la

8 · CONGESTIVA: TOLERANCIA Y COMPLICACIONES

Insuficiencia congestiva o global
fallan ambos ventrículos: síntomas y signos

según la carga, se tolera

en el riñón produce

con las cuatro cavidades afectadas da

Tolerancia
la sobrecarga de volumen (insuficiencia mitral o aórtica) se tolera años; la de presión (estenosis aórtica) descompensa antes

Complicaciones cardíacas y pulmonares
arritmias, shock cardiogénico, edema agudo de pulmón y tromboembolia pulmonar

Complicación renal
insuficiencia renal aguda o crónica

sin tratamiento llevan al

si es de presión, descompensa y lleva al

sin tratamiento llevan al

Las complicaciones llevan a **shock, falla respiratoria o falla renal**

síndrome · concepto · causa · mecanismo · diagnóstico · síntoma · signo · complicación · desenlace · técnica · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología General — Aparato cardiovascular, temas 8 y 5g (2020); SOTITO 2018 — teoría del docente (🧤 = literatura)